

TEMA 6.24 • INFECTOLOGÍA

Infección de Piel y Partes Blandas

PERFIL EUNACOM 1.05.1.024

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

# Infecciones de Piel y Partes Blandas

**Agentes más comunes:** *Staphylococcus aureus* (SA) y *Streptococcus pyogenes* (SP Grupo A). **Diagnóstico:** Clínico en todos los casos. **Principio:** Lo que cubre SA cubre también SP (no al revés). Ante la duda → cubrir SA.

Tabla Comparativa

| TABLA 6.24.1: ENFERMEDAD VS AGENTE |                                                         |                                                                                                   |                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ENFERMEDAD                         | AGENTE                                                  | CLÍNICA DIFERENCIADORA                                                                            | TRATAMIENTO                                                       |
| Erisipela                          | Solo SP                                                 | Placa eritematosa, <b>bordes muy nítidos</b> , linfangitis, fiebre alta                           | <b>Penicilina G EV</b>                                            |
| Celulitis                          | SA y SP                                                 | Placa eritematosa, <b>bordes difusos</b> (difíciles de definir)                                   | <b>Cloxacilina o Cefazolina EV</b>                                |
| Fasceítis Necrotizante             | SP (o polimicrobiana en diabético/Gangrena de Fournier) | Placa <b>muy dolorosa</b> , violácea-negra con necrosis, bulas hemorrágicas. Urgencia quirúrgica. | <b>Penicilina G EV + Clindamicina + Desbridamiento quirúrgico</b> |
| Shock Tóxico                       | SA o SP productores de exotoxina                        | Hipotensión refractaria + fiebre + eritrodermia (SA especialmente)                                | ATB EV + Clindamicina + Suero + Noradrenalina                     |
| Síndrome de Piel Escaldada         | SA (toxina exfoliativa)                                 | Eritema periorcular → bulas → despegamiento epidérmico. <b>Signo de Nikolsky (+)</b>              | <b>Cloxacilina EV + Clindamicina + hidratación</b>                |
| Impétigo                           | SA y SP                                                 | Costras mielicéricas alrededor de boca/nariz ("boca de payaso")                                   | Oral: Cloxacilina/Cefalexina, o Tópico: Mupirocina                |
| Impétigo Bulloso                   | SA (toxina exfoliativa localizada)                      | Igual al impétigo + bulas flácidas                                                                | Mismo que impétigo                                                |

Infecciones del Folículo Piloso

| TABLA 6.24.2: ENFERMEDAD VS AGENTE |                                     |                                                       |                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ENFERMEDAD                         | AGENTE                              | CLÍNICA                                               | TRATAMIENTO                                             |
| Foliculitis                        | SA (o Pseudomonas en sauna/piscina) | Pústulas en folículo piloso. Zona de barba o genital. | Cloxacilina VO (o Ciprofloxacino si Pseudomonas)        |
| Furúnculo                          | SA                                  | Como foliculitis pero más grande y profundo           | Nada / Cloxacilina VO / drenaje                         |
| Ántrax estafilocócico              | SA                                  | Varios furúnculos agrupados en masa inflamatoria      | <b>Cloxacilina o Cefazolina EV + Drenaje quirúrgico</b> |

Resumen de ATB por gravedad

| TABLA 6.24.3: GRAVEDAD VS FÁRMACO BASE |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| GRAVEDAD                               | FÁRMACO BASE             |
| Leve (VO)                              | Cloxacilina / Cefalexina |
| Grave (EV)                             | Cloxacilina / Cefazolina |
| Alérgico                               | Clindamicina             |
| SAMR                                   | Vancomicina EV           |

| Cuadro grave (fasceítis, shock, piel escaldada) | Agregar **Clindamicina EV** (↓ producción de toxinas) |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**  
"Paciente presenta placa eritematosa en pierna derecha con bordes difíciles de delimitar, fiebre de 38°C y dolor local moderado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?"

**EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:**  
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Infección de Piel y Partes Blandas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

EUNACOM CRITERIOS

**Fasceítis → 3 claves:** dolor intenso → sospechar / RMN confirmar → desbridamiento quirúrgico de urgencia.

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- Grampositivos: *S. pyogenes* (penicilina, 0% resistencia) y *S. aureus* (cloxacilina/cefazolina; MRSA = vancomicina). Todo lo que cubre SA cubre SP.
- Erisipela (SP): bordes NÍTIDOS, compromiso linfático. Celulitis (SA): bordes DIFUSOS. Ante duda: cubrir SA.
- Fascitis necrotizante (SP): placa violácea/necrótica, dolor intenso, bulas hemorrágicas. Penicilina + clindamicina EV + debridación quirúrgica URGENTE.
- Shock tóxico (SA o SP, exotoxina 1): hipotensión refractaria. Eritrodermia = orienta a SP. Tratamiento: ATB + clindamicina + noradrenalina.
- Piel escaldada (SA, toxina exfoliativa): desprendimiento epidérmico, signo de Nikolsky (+). Cloxacilina + clindamicina EV + hidratación como gran quemado.
- Impétigo: costras melicéricas periorales (boca de payaso). Tratamiento tópico (mupirocina) u oral. Impétigo buloso (SA): agrega bulas flácidas.
- Clindamicina se agrega en cuadros GRAVES (fascitis, shock tóxico, piel escaldada) para disminuir producción de toxinas.
- Foliculitis del sauna: *Pseudomonas aeruginosa*, tratamiento con ciprofloxacino. Ántrax estafilocócico: furúnculos confluentes, cloxacilina EV + drenaje.

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INFECCIÓN DE PIEL Y PARTES BLANDAS)****PREGUNTA 1**

Paciente presenta placa eritematosa en pierna derecha con bordes difíciles de delimitar, fiebre de 38°C y dolor local moderado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?

- A)** Erisipela; penicilina G endovenosa
- B)** Celulitis; cloxacilina o cefazolina endovenosa
- C)** Fascitis necrotizante; penicilina más clindamicina y cirugía
- D)** Impétigo; mupirocina tópica
- E)** Celulitis; penicilina oral

**PREGUNTA 2**

Lactante de 6 meses presenta eritema periocular que progresa a bulas en pliegues que se rompen con desprendimiento epidérmico al presionar con el dedo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- A)** Penicilina G endovenosa
- B)** Cloxacilina endovenosa más clindamicina endovenosa más hidratación
- C)** Corticoides sistémicos
- D)** Vancomicina endovenosa
- E)** Mupirocina tópica solamente

**PREGUNTA 3**

Paciente diabético con herida infectada en pie presenta placa violácea que avanza rápidamente con zonas necróticas y bulas hemorrágicas. ¿Cuál es la conducta más urgente?

- A)** Antibióticos endovenosos y reevaluar en 24 horas
- B)** Solicitar RMN para confirmar fascitis antes de operar
- C)** Antibióticos endovenosos (penicilina + clindamicina) más debridación quirúrgica urgente
- D)** Cloxacilina endovenosa y curación avanzada de heridas
- E)** Vancomicina endovenosa por sospecha de MRSA en diabético

**RESUMEN: INFECCIÓN DE PIEL Y PARTES BLANDAS**

Esta clase aborda las infecciones de piel y partes blandas, causadas por bacterias grampositivas (*S. aureus* y *S. pyogenes*). El diagnóstico es clínico en todas. El tratamiento del *S. pyogenes* leve es con amoxicilina/ampicilina oral, grave con penicilina G EV; alérgicos con azitromicina o clindamicina (0% resistencia a penicilina). Para *S. aureus* leve: cloxacilina/flucloxacilina/cefadroxilo oral, grave: cloxacilina/cefazolina EV; alérgicos solo clindamicina; resistente (MRSA): vancomicina. En cuadros graves se agrega clindamicina EV (disminuye producción de toxinas). La erisipela (*S. pyogenes*) produce placa eritematosa con bordes NÍTIDOS, compromiso linfático, fiebre alta; tratamiento con penicilina EV. La celulitis (*S. aureus*) produce placa con bordes DIFUSOS; tratamiento con cloxacilina/cefazolina. La fascitis necrotizante (*S. pyogenes*) produce placa dolorosa, violácea, con necrosis y bulas hemorrágicas; tratamiento con penicilina + clindamicina EV más debridación quirúrgica urgente. El shock tóxico (*S. aureus* o *S. pyogenes* con exotoxina 1/superantígeno) produce hipotensión refractaria; si eritrodermia orienta a *S. pyogenes*. El síndrome de piel escaldada (*S. aureus*, toxina exfoliativa) produce desprendimiento epidérmico con signo de Nikolsky; tratamiento con cloxacilina + clindamicina EV. El impétigo (ambos) produce costras melicéricas periorales; tratamiento tópico (mupirocina) u oral. El impétigo buloso (*S. aureus* con toxina exfoliativa) agrega bulas flácidas. La foliculitis (*S. aureus*): pústulas en folículos pilosos, si del sauna es por *Pseudomonas* (ciprofloxacino). El furúnculo: foliculitis grande, manejo conservador o drenaje. El ántrax estafilocócico: masa de furúnculos confluentes, cloxacilina/cefazolina EV + drenaje quirúrgico.